

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062267-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: FLAVIO ALEXANDRE MASSA GUIMARAES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ALERGIA ALIMENTAR GRAVE COM ANAFILAXIA. RISCO DE ÓBITO. MENOR IMPÚBERE. PRESCRIÇÃO DE EPINEFRINA AUTOINJETÁVEL. PRECEDENTES STF. RE 657718 (TEMA 500) E RE 1165959 (TEMA 1161). INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS TEMAS VINCULANTES, SOBRETUDO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5062267-11.2024.4.02.5101

510014330446 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062267-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: FLAVIO ALEXANDRE MASSA GUIMARAES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida Cautelar interposta pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para fornecimento MU - epinefrina auto injetável - sem registro na Anvisa. Vejamos:

*"Trata-se de ação proposta por **Flavio Alexandre Massa Guimarães** em face da **União, do Estado do Rio de Janeiro** e do **Município do Rio de Janeiro** com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento de Adrenalina/Epinefrina auto injetável.*

*Breve relatório. **Decido.***

A tutela de urgência exige a presença dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O eg. STJ firmou a seguinte tese, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156, sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
- (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência..”

No caso vertente, o autor apresenta documento médico em que está prescrita adrenalina auto injetável por anafilaxia por causa alimentar e IgE específicas positivas para os alimentos precursores da reação descrita (evento 1 - ANEXO2).

A Câmara de Resolução de Litígios em Saúde informa que o medicamento pleiteado não possui registro válido na ANVISA (Evento 1 - ANEXO2).

De acordo com o parecer do NAT (Evento 14), o fármaco não possui registro na ANVISA, configurando produto importado, e não se encontra padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

Esclarece que o medicamento está indicado para manejo do quadro clínico do autor.

Salienta que o registro de medicamentos é um dos meios estabelecidos pela Política Nacional de Medicamentos pelo qual a autoridade sanitária avalia a relevância terapêutica do medicamento, analisa sua segurança e qualidade. Medicamentos ainda sem registro não possuem diretrizes nacionais que orientem seu uso.

Acrescenta que todo paciente (ou seu responsável) em risco de sofrer nova reação anafilática deve saber reconhecer precocemente os sinais de uma crise, portar e saber aplicar a medicação de emergência.

Informa que o Ministério da Saúde ainda não publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas que verse sobre a anafilaxia à intolerância alimentar e não há alternativas terapêuticas fornecidas no SUS que possam representar substitutos farmacológicos ao medicamento vindicado.

Sendo assim, considerando a tese firmada no Recurso Repetitivo acima citado e que o pedido é de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS sem registro na ANVISA, entendo que não restou demonstrado o preenchimento do terceiro requisito para a concessão do medicamento.

A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 657718, decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), salvo em casos excepcionais, fixando a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral:

“1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

I - a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras;

II - a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;

III - a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União.” (negritei)

Nesses termos, apesar de ser excepcionalmente possível o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA por decisão judicial, diante do acima exposto, entendo que, nesta fase processual, não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos acima elencados, não estando presente a probabilidade do direito invocado.

No mesmo sentido já decidiu a Eg. 8ª Turma Recursal nos Recursos de Medida Cautelar Cível nº 5029186-71.2024.4.02.5101 e 5035929-97.2024.4.02.5101.

Ressalto ainda que o autor informa que não possui autorização para importação (evento 21).

Desse modo, neste juízo de cognição sumária, mostra-se forçoso o indeferimento do provimento liminar pretendido.

Assim, **indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela**, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.259/01, c/c art. 300, do Código de Processo Civil.”

A decisão do evento 3 indeferiu a liminar.

A parte autora interpôs agravo interno, pretendendo a reconsideração da decisão do evento 3 ou, no caso de caso não reconsideração, seja apresentado ao colegiado da 8ª Turma Recursal para julgamento.

VOTO

Entendo não ser o caso de reconsideração da decisão, e submeto o agravo ao colegiado, para julgamento conjunto com a medida de urgência interposta.

Mantenho o já fundamentado na decisão do evento 3, que passa a fazer parte integrante do presente voto, com alguns acréscimos. Vejamos:

Alega o autor estar em acompanhamento na rede privada de saúde, e ter sido diagnosticado com ANAFILAXIA POR CAUSA ALIMENTAR (CID 10 T78) e IgE específicas positivas para os alimentos precursores da reação, referindo angioedema de face e edema de laringe associados à vertigem e hipotensão, com risco de asfixia, choque e risco efetivo de morte.

Dessa forma, informa ter sido prescrito 01 caneta de ADRENALINA AUTO-INJETÁVEL, em razão da adrenalina intramuscular apresentar resposta imediata, eficaz e segura, sendo considerado o tratamento de primeira linha para a patologia em comento.

Vejamos as informações contidas na prescrição médica:

LAUDO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRM: 52-126502-4
Nome: RENATO MONTEIRO DE ALMEIDA MAGALHÃES
Endereço: Rua Correia Dutra, 62, Flamengo, Rio de Janeiro
Telefone: (35) 99911-4212

PACIENTE: Flávio Alexandre Massa Guimarães

Descrição:
Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2024

Caro(a) avaliador(a),
Este instrumento tem como objetivo solicitar o fornecimento de 01 Epi-Pen (uma caneta de adrenalina autoinjetável) de forma anual para o Sr. Flavio Alexandre Massa Guimarães, masculino, 34 anos, prontuário 2727248, atendido na Clínica Pastore; Paciente possui quadro comprovado de anafilaxia por intolerância alimentar (CID: T78).

A doença tem causado transtornos nas atividades diárias do paciente, inclusive em sua vida social. O tratamento da anafilaxia requer uma resposta imediata, sendo a adrenalina intramuscular o tratamento de primeira linha.

A administração precoce é crucial para prevenir a progressão a sintomas que representem risco de vida. A adrenalina auto injetável é eficaz e segura, sendo recomendada como o padrão-ouro no tratamento da anafilaxia.

Venho aqui solicitar o fornecimento de uma (01) Caneta de Adrenalina Auto-Injetável anualmente ao paciente supracitado, uma vez que a administração desta é o único medicamento capaz de reverter com segurança uma anafilaxia, sendo descrito e indicado em consenso internacional que pacientes com histórico comprovado de anafilaxia tenham consigo caneta auto-injetável de adrenalina. (CID: T78). Grato!

Data de geração: 16/06/2024 14:47 - Validade: 13/12/2024



Utilize o QR Code ao lado ou acesse a URL para validação:
<https://www.cremelj.org.br/servicomedico/documentomedico/validar>
CRM: 126502-4
Código de Validação: ba63415f-48eb-491c-844d-32148dd292bc

Não há norma que exija a aposição de carimbo na receita Médica, de acordo com o Parecer CFM n. 01/14. A ANS entende que a prescrição feita remotamente é equivalente àquelas apresentadas em receituário de papel, para fins de realização do procedimento junto à rede prestadora do plano. Atenta-se à NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/COMEC/GEAS/GRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, da ANS. Em caso de problemas com operadoras de saúde, o prestador/usuário poderá entrar em contato com a ANS, pelo telefone 0800 701 9656.

Leia o QR Code ao lado e veja os dados do seu médico no CREMERJ



CREMERJ Plataforma desenvolvida pelo CREMERJ

A Câmara de Resolução de Litígios esclarece que o SUS disponibiliza anti-histamínicos, corticosteroides, broncodilatadores e adrenalina, mas não na forma autoinjetável, por não haver registro na Anvisa (Evento 1, ANEXO2 fl. 16).

Parecer do Nat informa que a Adrenalina (Epinefrina) autoinjetável está indicada ao quadro clínico da parte autora, não possui registro na Anvisa e não se encontra padronizada. Até o presente momento, não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas que verse sobre alergia alimentar, razão pela qual não há lista oficial de medicamentos (evento 14).

Desta forma, não há substitutos terapêuticos.

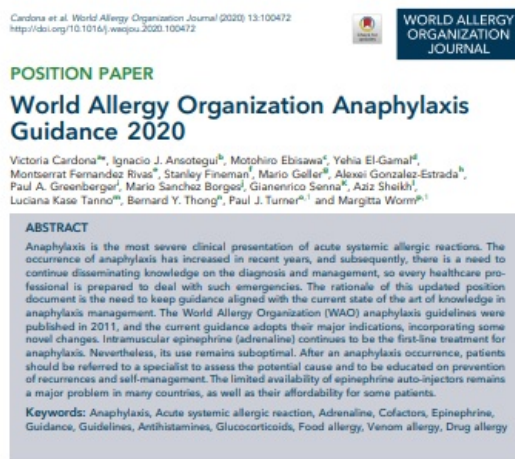
Salienta ainda que, segundo orientação da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia para o tratamento emergencial de anafilaxia, todo paciente (ou seu responsável) em risco de sofrer nova reação anafilática deve saber reconhecer precocemente os sinais de uma

crise, portar e saber aplicar a medicação de emergência. Informa que este kit deve conter: comprimidos de antihistamínico (anti-H1) e de corticosteroide, além de agente β 2-agonista spray, e, se as reações anteriores foram graves é aconselhável dispor de adrenalina e anti-histamínico para aplicação, já que úteis os aplicadores auto injetáveis de Epinefrina nessa situação.

Pois bem.

Conforme orçamentos apresentados pela Autora, o preço médio do insumo varia de R\$ 915,00 a R\$ 1.750,00. Considerando que a prescrição médica é de 1 caneta anula, configurada a competência dos Juizados Especiais Federais.

Este Juízo, por ocasião de julgamento de recurso análogo, analisou documento que apresentava informações de que, apesar de não se verificar o registro de auto injetáveis de adrenalina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há consenso internacional elaborado pelo World Allergy Organization (WAO) sobre o uso da Epinefrina, bem como a importância do dispositivo auto injetável de adrenalina. Vejamos o documento em questão:



O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 657718, em sede de repercussão geral, em 22/05/2019, fixou a seguinte tese no tocante ao fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registro na ANVISA:

"O Plenário, por maioria de votos, fixou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral:

- 1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.*
- 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.*
- 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:*

I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras;

II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;

III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

- 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União."*

Pois, o registro na ANVISA constitui proteção à saúde pública, atesta a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país e garante o devido controle de preços. O registro sanitário por agência estatal é ferramenta que garante a proteção à saúde pública ponderando interesses de empresas farmacêuticas, pesquisadores, médicos e pacientes na aceção individual e coletiva (saúde pública).

Outrossim, no caso de medicamentos experimentais, ou seja, sem comprovação científica de eficácia e segurança não deve o Poder Judiciário determinar o fornecimento. Pois, se por um lado há o direito à saúde, o Estado de forma responsável sem substrato em pesquisas quanto à segurança e eficácia, não deve concluir pelo direito ao fornecimento.

Contudo, no caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, ainda que não exista registro na ANVISA, a questão tem outros contornos, sendo possível o fornecimento judicial em caráter absolutamente excepcional, o qual pressupõe irrazoável mora da ANVISA em apreciar o pedido e comprovação dos itens I, II e III acima.

Para o caso em questão, embora a forma específica de aplicação da adrenalina não esteja registrada na ANVISA, verifica-se que não se trata de medicamento experimental, vez que a Adrenalina injetável é padronizada no SUS para uso hospitalar.

Por fim, ressalto que Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Especificamente sobre o medicamento Epinefrina, há decisão recente da Ministra Rosa Weber, entendendo ser possível o fornecimento do medicamento, levando-se em consideração, ainda, que a ANVISA tem autorizado a importação do mesmo. Vejamos:

RE 1365078 / PR - PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 17/06/2022. Publicação: 24/06/2022. Publicação. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23/06/2022 PUBLIC 24/06/2022 Partes. RECTE.(S) : UNIÃO PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO RECDO.(A/S) : ISADORA CHIARATO MATULA ADV.(A/S) : DEBORA GOELDNER PEREIRA OLIVEIRA RECDO.(A/S) : VIVIAN CRISTINA CHIARATO MATOS ADV.(A/S) : DEBORA GOELDNER PEREIRA OLIVEIRA RECDO.(A/S) : ESTADO DO PARANA ADV.(A/S) : AUDREY SILVA KYT RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE MANDAGUARI ADV.(A/S) : STAEEL MARIA DE OLIVEIRA INTDO.(A/S) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ADV.(A/S) : JOAO GUALBERTO GARCEZ RAMOS

Decisão

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Vistos etc.

Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alega impossibilidade de condenação do Estado a fornecer medicamento não registrado na ANVISA. Sustenta violação do princípio da isonomia. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 196 e 197 da Lei Maior.

É o relatório.

Decido.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos.

A Primeira Turma Recursal do Paraná manteve a decisão pela qual indeferido o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, em que pleiteado o fornecimento do medicamento para tratamento oncológico. O acórdão recorrido está assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ADRENALINA AUTO-INJETÁVEL. MEDICAMENTO QUE EMBORA NÃO SEJA EXPERIMENTAL, NÃO ESTÁ REGISTRO NA ANVISA PARA A FORMA ESPECÍFICA DE APLICAÇÃO. TRATAMENTO ASSEGURADO.

1. Admite-se, em hipóteses particulares, o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos e relações complementares do sistema público de saúde, desde que imprescindíveis ao tratamento necessário à proteção da saúde do usuário e uma vez observados os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

2. Em relação à adrenalina auto-injetável, a perícia médica realizada atestou o uso altamente eficaz do medicamento na contenção de crises anafiláticas. Assim, cuidando-se de portador de alergia alimentar múltipla, mostra-se inviável submeter a parte à alternativa terapêutica oferecida pelo SUS, cujo tratamento disponível exige certo conhecimento e técnica para aplicação da adrenalina. Portanto, em situações emergenciais, é imprescindível a utilização do fármaco pleiteado, visto o real risco de morte oriundo das crises anafiláticas.

3. Embora esta forma específica de aplicação de adrenalina não esteja registrada na ANVISA, obviamente não se trata de medicamento experimental, uma vez que o SUS fornece adrenalina para uso hospitalar. Além disso, a ANVISA tem autorizado a importação da adrenalina autoinjetável (<http://www.alergopneumoped.com.br/arquivos/site/informacoespacientes/EpiPen-como%20adquirir.pdf>).

4. Recurso improvido.”

Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.

O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que **“cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”** (Tese nº 1.161 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’ (RE 1165959, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(A) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 22.10.2021).

Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.

Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2022.

Ministra Rosa Weber

Relatora

Observação

13/07/2022 Legislação feita por:(NCF).

Legislação

LEG-FED CF ANO-1988 ART-00102 INC-00003 ART-00196 ART-00197 CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG-FED LEI-013105 ANO-2015 ART-00085 PAR-00002 PAR-00003 PAR-00011 CPC-2015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL LEG-FED RGI ANO-1980 ART-00021 PAR-00001 RISTF-1980 REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LEG-FED SUMSTF-000279 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

Contudo, este Juízo tem entendido, considerando-se que para o fornecimento do medicamento será necessário fazer distinção em relação aos temas vinculantes, sobretudo do STF, ainda que já exista precedente monocrático no STF acima reproduzido, não antecipar os efeitos da tutela.

Entendimento, este, inclusive que deverá ser cotejado com o recente tema 1234 do STF, sobre medicamentos não padronizados.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5062267-11.2024.4.02.5101

510014330445 .V4